



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : نجيه محمد عبدالله طنطاوي

المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : البساتين

العنوان : 24 ش- احمد عبد الجليل

تاريخ تسجيل الإستمارة : 27-09-2026

رقم البطاقة : 25109100101307 رقم التليفون : 01112070563

العمر (تاريخ الميلاد) : 10-09-1951 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نجيه محمد عبدالله طنطاوي National ID: 25109100101307	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جَبَّار 20 اَلْاِسْتِغْلَامِ رِسْمِ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

2026-7-6 : 9-6 : 7-6

.....

التامين التأمين الاجتماعى الاجتماعى

الإحصاء رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والتعليمات"

والأولى " 86 لسنة 2012 رقم وقانوني و المداير بطاقي الخاص 99 لسنة 1992

١٤٢٨هـ. المجلة العلمية بالمرحوم ٢٠١٢ لسنة ٢٣ وقانون "المدرسي" السجل الدولي ١٤٢٨هـ.

[illegible]

الاختصاص الضمان من المصلحة المبتات التياتة وقا قة وقا قة

والله اعلم

25109100101307 بظاہر اور باطنی محمد علی علیہ السلام (۵) السلام

خروج : ۱۰۰۰

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

الشماسي الشامي الصحي التامين القاتون الموانع خضوع حال جاني الصحي التامين العامة

2026-7-6: 4:50 PM

الموظف المختص
سليم
محمود عبد الله

॥ अथ श्रीमद्भगवत्पञ्चविंशोऽध्यायः ॥

2015012

[illegible]

الإقامة الموقفية للمعلمين و التحويلات

Patient ID: 96946	Patient Name English: Nagiah Mohamed Abdallah
Age: 47	2026/07/06 12:09:10 PM : Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The right breast shows posterior 1/3 large dense mass lesion with macro an microcalcifications.

- Ultrasound revealed large hypoechoic mass lesion measures about 5.0 x 4 cm at its maximum diameters and located at 11 ° clock position with internal vascularity.

- Normal nipple/areolar complex.
- Prominent axillary lymph nodes with mild cortical thickness reaching 3 mm.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.

- Ultrasound demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.

- Multiple small dispersed subcentimetric thin-walled anechoic cysts.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Right breast (BIRADS 5): Right UOQ malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary as described. For tru cut biopsy.
- Left breast (BIRADS 2): left breast fibrocystic changes.

Much obliged,

Dr. Rania Mohamed



جيهه الاصدار :فرع القاهرة

رسوم الاستعلام 20 جنيه

تاريخ الاصدار :6-7-2026

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للائتماع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والأرامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الأطفال دون السن المدرسي " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسة من الضمان الاجتماعي
والبحت تبين أن

السيد (ة) نجية محمد عبدالله بطاقة رقم 25109100101307

تليفون رقم: لا يوجد
وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية بغير عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنقعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي خال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

الموظف المختص
محمود عبدالله

تاريخ الطباعه :6-7-2026

إفادة مركز نظم المعلومات

يتمتع بـ



مسجل 2015012

الخطاب سري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية و التعليم

الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقمي

جمهورية مصر العربية
بطاقة هوية شخصية

نجله
محمد عبدالله طنطاوي
٢٤ ش احمد عبدالجليل
البنسطين - القاهرة

٢٥١٠٩١٠٠١٠١٣٠٧

٢٩٥٧/٠٦/٢٠٠٧

IX7084822

٢٠٢١/٠٦
٢٥١٠٩١٠٠١٠١٣٠٧
مجلسه بوزارة الداخلية سابقا

أرملة
مستلمة
أنش

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٦/٢١

١

تعرفي على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي

الخطوة الرابعة (على السرير)

- استلقي على السرير، استخدم يدي اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.

- باستخدام أطراف أصابعك و من خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).

- تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.

- حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبداي من الحلمة ثم تتحركي في دوائر أكبر وأكبر حتى تصلي إلى المنطقة الخارجية للثدي.

- يمكنك أيضاً تحريك أصابعك لأعلى ولأسفل رأسياً.

- لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:

الشعور بأورام بالإبط الشعور بسمك عام

ورم محسوس

ألم بالثدي

الخطوة الخامسة (أثناء الإستحمام)

- أعيدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الإستحمام والجلد مبلل.

الخطوة الأولى (أمام المرأة)

- انظري إلى الثديين في المرأة مع وضع اليدين في وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.

- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لكي دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.

- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين :

طفح

حدوث تجوف

تغير في الشكل أو الحجم

بروز الأوردة

تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة
تقرحات بالجلد أو الحلمة

الإحمرار

تجاعيد بالجلد تحول الجلد لما يشبه قشر البرتقال

الخطوة الثانية (أمام المرأة)

- إرفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغيرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرأة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى

إفرازات غير طبيعية أو دم

في حال ملاحظة أي من العلامات السابقة توجهي إلى عيادة صحة المرأة بالوحدة الصحية

- أفضل توقيت لتقومي بالفحص الذاتي للثدي بعد آخر يوم في الدورة الشهرية أو في حالة إنقطاع الدورة الشهرية حدي يوم ثابت شهرياً لإجراء الفحص.



Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي الدولي للأناتومي المرضية - مصر



Patient Name	نجيبة محمد عبدالله	Case No.	340821
Sex/Age	Female 74 Y	Patient No.	24542
Registered Date	08/7/2026 09:42:04 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	05/8/2026 01:31:46 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	05/8/2026 01:41:20 PM	Pathology No.	2135/26

Clinical Data: Right breast UOQ mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 08/07/2026.

Gross Examination:

- Six grey, white tissue cores, ranging in size between 1.0 cm & 1.2 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- CK clone (AE1/AE3), CD34 (Qbend10), ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive metaplastic carcinoma (Matrix forming).
- Histologic grade: 3 (Differentiation 3, pleomorphism 3, mitosis 2).
- Ductal carcinoma in situ: Absent.
- Angio-invasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- CK: Focally positive.
- CD34: Negative.



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الطبية - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Miter El Qandama - Cairo, Egypt

Patient Name	نجيه محمد عبدالله	Case No.	340821
Sex/Age	Female 74 Y	Patient No.	24542
Registered Date	08/7/2026 09:42:04 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	05/8/2026 01:31:46 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	05/8/2026 01:41:20 PM	Pathology No.	2135/26

- ER: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 90%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive metaplastic carcinoma (Matrix forming), Grade 3. IPT:
- CK: Focally positive.
- CD34: Negative.
- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67%: 90%.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by





Gustave Roussy International-Lgypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترنشيونال - مصر - مصر عمل الباثولوجي



Patient Name	نجيه محمد عبدالله	Case No.	340821
Sex/Age	Female 74 Y	Patient No.	24542
Registered Date	08/7/2026 09:42:04 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	05/8/2026 01:31:46 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	05/8/2026 01:41:20 PM	Pathology No.	2135/26

membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature:

Prof. Dr. Gamal Abd El-Atty.

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



غرفة رقم (14) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - مخبر نقيش النيل - مصر الطبية - القاهرة 3 - مصر
Room No. (14) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mistr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient ID: 96946	Patient Name English: Naglah Mohamed Abdallah
عمر ١٧ سنة، ٩ أشهر	2026/07/06 12:09:10 PM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The right breast shows posterior 1/3 large dense mass lesion with macro an microcalcifications.
- Ultrasound revealed large hypoechoic mass lesion measures about 5.0 x 4 cm at its maximum diameters and located at 11 ° clock position with internal vascularity.
- Normal nipple/areolar complex.
- Prominent axillary lymph nodes with mild cortical thickness reaching 3 mm.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Multiple small dispersed subcentimetric thin-walled anechoic cysts.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Right breast (BIRADS 5): Right UOQ malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary as described. For tru cut biopsy.
- Left breast (BIRADS 2): left breast fibrocystic changes.

*Much obliged,
Dr. Rania Mohamed*



جيهه الاصدار :فرع القاهرة

رسوم الاستعلام 20 جنيه

تاريخ الاصدار :6-7-2026

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للائتماع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والأرامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الأطفال دون السن المدرسي " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسة من الضمان الاجتماعي
والبحت تبين أن

السيد (ة) نجية محمد عبدالله بطاقة رقم 25109100101307

تليقون رقم: لا يوجد
وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية بغير عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنقعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي خال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه :6-7-2026

الموظف المختص
سماح
محمود عبدالله



إفادة مركز نظم المعلومات

يتمتع



مسجل 2015012

الخطاب سري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية و التعليم

الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقمي

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



نبيه
محمد عبدالله طنطاوي
٢٤ ش احمد عبدالجليل
البنسطين - القاهرة

١٩٥٨/٠٦/٢٥

٢٥١٠٩١٠٠١٠١٣٠٧

IX7084822



٢٠٢١/٠٦

٢٥١٠٩١٠٠١٠١٣٠٧

مجلسية بوزارة التضامن سابقا

ارملة

انثى

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٦/٢١

١



تعرفي على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي

الخطوة الرابعة (على السرير)

- استلقي على السرير، استخدم يدي اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.

- باستخدام أطراف أصابعك و من خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).

- تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.

- حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبداي من الحلمة ثم تتحركي في دوائر أكبر وأكبر حتى تصلي إلى المنطقة الخارجية للثدي.

- يمكنك أيضاً تحريك أصابعك لأعلى ولأسفل رأسياً.

- لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:

الشعور بأورام بالإبط الشعور بسمك عام

ورم محسوس

ألم بالثدي

الخطوة الخامسة (أثناء الإستحمام)

- أعيدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الإستحمام والجلد مبلل.

الخطوة الأولى (أمام المرأة)

- انظري إلى الثديين في المرأة مع وضع اليدين في وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.

- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لكي دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.

- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين :

طفح

حدوث تجوف

تغير في الشكل أو الحجم

بروز الأوردة

تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة تقرحات بالجلد أو الحلمة

الإحمرار

تحول الجلد لما يشبه قشر البرتقال

الخطوة الثانية (أمام المرأة)

- إرفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغييرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرأة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى

إفرازات غير طبيعية أو دم

في حال ملاحظة أي من العلامات السابقة توجهي إلى عيادة صحة المرأة بالوحدة الصحية

- أفضل توقيت لتقومي بالفحص الذاتي للثدي بعد آخر يوم في الدورة الشهرية أو في حالة إنقطاع الدورة الشهرية حدي يوم ثابت شهرياً لإجراء الفحص.

Patient Name	نجيبه محمد عبدالله	Case No.	340821
Sex/Age	Female 74 Y	Patient No.	24542
Registered Date	08/7/2026 09:42:04 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	05/8/2026 01:31:46 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	05/8/2026 01:41:20 PM	Pathology No.	2135/26

Clinical Data: Right breast UOQ mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 08/07/2026.

Gross Examination:

- Six grey, white tissue cores, ranging in size between 1.0 cm & 1.2 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- CK clone (AE1/AE3), CD34 (QBend10), ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive metaplastic carcinoma (Matrix forming).
- Histologic grade: 3 (Differentiation 3, pleomorphism 3, mitosis 2).
- Ductal carcinoma in situ: Absent.
- Angio-invasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- CK: Focally positive.
- CD34: Negative.



Patient Name	نسيبه محمد عبدالله	Case No.	340821
Sex/Age	Female 74 Y	Patient No.	24542
Registered Date	08/7/2026 09:42:04 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	05/8/2026 01:31:46 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	05/8/2026 01:41:20 PM	Pathology No.	2135/26

- ER: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 90%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive metaplastic carcinoma (Matrix forming), Grade 3.
- IPT:
- CK: Focally positive.
- CD34: Negative.
- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67%: 90%.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by



Patient Name	نجيه محمد عبدالله	Case No.	340821
Sex/Age	Female 74 Y	Patient No.	24542
Registered Date	08/7/2026 09:42:04 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	05/8/2026 01:31:46 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	05/8/2026 01:41:20 PM	Pathology No.	2135/26

membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature:

Prof. Dr. Gamal Abd El-Atty.

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



غرفة رقم (14) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - مخبر نسيج الخلية - مصر الطبية - القاهرة 3 - مصر
Room No. (14) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mistr El Qadema - Cairo, Egypt

